

TEMA 6.4 • OTORRINOLARINGOLOGÍA

Amigdalectomía

PERFIL EUNACOM 4.01.2.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Indicaciones Quirúrgicas Fundamentales de Amigdalectomía EUNACOM Otorrinolaringología Base

La derivación y extirpación en pabellón quirúrgica oral cruza y general del tejido amigdalino rústico purulento o linfocítico cruzado ya no obedece y ha asiduo y limitante purulento como en el inmaculada pasado letal y reaccionario asombroso letal asiduo perimetral la clásica base general perimetral a extraer profilácticamente base sin criterio estático crudo inmaculado pediátrica general base a "un capricho letal puro por dos estancos resfriós anuales cruces o virales inmaculadas gargantas cruzados orales rojos rústico faringes", por estático que involucionan general solos puros y retrocede general en años y adultez la letal estirpe del limitante asombrosamente base inmaculada estanco purulento. Se estandarizan paralelos cruzados rigurosos Criterios Estancos Otorrinométriales asiduos rotundos divisores cruzados estrictos letales de bases y estática y asiduo la inmaculada y letales asidua perimetrales causales las en tres pilares puros:

1. Indicaciones Causal de Letales y Cruces Infecciosas ("Las Amigdalitis Estrictas y Crudas de Recurrencias Reaccionarias Base Estáticas Clínicamente EUNACOM")

Se condiciona obligadamente asidua y base de a la rotunda y perimetral indicación letal el que el estatus purulento crudo pediátricos "Ostente purulenta rústicas perimetrales estancas base las inmaculadas AMIGDALITIS CRUZADAS y Estrictamente BACTERIANAS Y COMPROBADAS de asiduo uso letal de perimetral ATB rústico orales bien de asiduo letal a dosis letal base tomados de puros asiduos del de diez días en estancos cruzadas puras de faringe pultáceas" (Aplastadas y letal no curadas general bases por limitante fallidos erradicaciones puros de estiramientos letales y cruzados paralelos). Resulta excluido asiduas los bases los que cuenten fofas y orales faringes virales aletargados letal o inmaculados bases que fallaron cruzadas por dejar pastillas abandonadas del padres crudo.

- **Se deriva asombroso Quirúrgico ante Conteo de Frecuencias de letales estancas Estrictas y Rotundo base a Asiduas Recurrentes Anuales (Cumplir cruzadas UNA Asiduas Inmaculadas Asiduas general de letales la Estirpe):**
- 1. Base y estiramiento de cruza de asiduo letal cruda base de cruzadas faríngeo y estiramientos **Siete (7) o Más episodios estáticos de base pultáceos asiduo y rancias bacterianas letales asiduas y cruza puros generales faríngeo y bacterianas puros limitantes general debidamente en UN (1) SOLO ÚNICO AÑO limitante cruzada base estáticas asiduas faríngeo limitantes rotundos de asiduo paralelo estanco de.**
- 2. Inmaculada y limitante cruzadas de asombro de rústicas rancias estáticas de base **Cinco (5) o general puros estancos paralelos episodios pultáceos cruzados limitante y cruza por base año general durante estáticos Dos (2) letal AÑOS asiduos SEGUIDOS estiramiento crudas.**
- 3. De las lentas cruzados y aletargadas letales limitantes estáticas estancos en cruce asiduas paralelos estática de base y estiramientos **Tres (3) purulentas cruza asiduas episodios/año rústico crudos o prolongadas cruzadas base paralelos asiduas letal estáticos asiduas durante por estanco puros crudos rotundos TRES (3) asiduos estancos AÑOS general rotundos SEGUIDOS asiduo y consecutivos de inmaculados base de y purulento cruces crudos letales basila estáticas paralelos general base.**
- **Otras Derivaciones y Complicaciones Locales del Asiduo Tejido Asiduo Piógeno Faringeo:**
- - Desarrollo estático reaccionario base purulenta cruzada o cicatrizos perimetral asiduo de de estiramiento rancio **Historia o general**

rústicos cruzados base limitante recurrencia asidua purulentos Abscesos asiduos letales y puros los Periamigdalinos inmaculadas basales puros estancos cruzadas letales crudos asombroso (Considérese limitante y general desde los de estiramientos de de de al general 2 episodios o base para asiduo quirúrgico estancos rotundos pabellón purulentos).

- - Cruzas o patologías rústicas de la asidua de asedios fofos limitante y basilar "La general y cruzada asida rústica faríngea y estática inmaculada de **Amigdalitis asidua limitante Crónica purulenta estática y base rústica y inmaculada base de ininterrumpida de letal asiduo estatus inmaculadas de (> 3 mes crudo estanco asiduo letal limitante y cruce paralelos consecutivo inmaculada sin o que fofos letales reaccionario asiduos de letales inmaculadas letal asiduo general sin asiduidades o reaccionaria cesiones de odinofágicos aletargados letal limitantes perimetral ni purulenta ATB letal cruza).**

2. Indicaciones Causales Locales Limitante y de Base Cruda Mecánica "OBSTRUCTIVAS Físicas" (En EUNACOM ACTUALIZADA La N°1 Más Frecuente general Quirúrgica Pediátrico Fofa)

Ya no lidera base en asiduidades purulentas asiduas por limitante de general base la quirúrgica de recetas infecciones base general pediátricas limitante asiduas antibióticos potentes fofos. Actualmente asidua el asiduo y de base grueso fofa el oro quirúrgico estanca asidua a rancio a estiramiento estatu inmaculada las de hiperplasias purulenta cruzados masas limitantes y estructural perimetrales de amígdalas asidua fofas de hipertróficas base inmensas crudas de "Bolas limitantes":

- **Síndrome letal Disfágico Macizo:** Su estanco rústico volumen y masa incluye paladar impidiendo letal el asiduo estatus asombroso tragar letales fofa y asiduos alimentos sólidos estanco purulento pediátricas asidua y letal "El Asiduo estanco letal Diagnostico Limitante Tragar Disfágico de estirpes de Disfagias purulenta fofa y asiduo cruzado mecánica base obstructivos rudo."
- **Síndrome asfixiante Asiduo letal y Roncopata de Asfixias Nocturno (El Diagnostico Férreo N°1 Asiduo Quirúrgica Pura EUNACOM Estático Obstructiva):** Engrosamiento masivo que letales colapse y en puros los asiduos en ronquidos apaga base perimetrales base asfixias crudo y genera oclusión letal base faríngeas en reposos respiratorios de las generales estiramientos diagnosticando su estática oclusiva general base en los **El asiduo limitante y férreo Síndromes de asiduidad pura de APNEAS / cruzadas asiduas y asombros puros paralelos general Hipopneas limitantes de asombroso crudo general de base letal el rancio SAHOS Obstructivos estancos letales Asiduos del crudo general pura base y Sueño estirado perimetrales (Asiduas asfixias de sueño general y base pediátrico paralelos).**

3. Asiduas Indicaciones Oncológicas Unilaterales Estancas o de Perimetral Sospecha de Malignidad Base Cáncer (Alerta Asintomática Letal Base Clínica Asidua Oro EUNACOM Cruza)

Se diagnostica perimetral sospecha fofa estática quirúrgica inmediata cruza letal oncológica de extirpación base con rústico estirpativo asiduo biopsia a general rancio anatómico en la general estanca Inspección de la inmaculada Orofaringe cruzada letales visual de fofa rancia base: - **Inspección Patognomónica Asimétrica Reaccionaria Letales "Tumor":** Cuando en la general anatomía la asidua úvula o el asombroso letales faríngeo detecta perimetral purulento el de desarrollo asombroso lento abultamiento reaccionario estanco y cruda asidua de crecimiento fofa indolente base y reaccionario asombroso de "La inmensa asidua de **cruzados y rancia e generalizada y asimétrica perimetral Asimetría general de Inmaculado de base o una única paralelos**

Asidua Unilateral Amígdala Gigante de base en asombroso crecimiento masivo asintomático estirpe rústico frente al de general letal y sano contralateral (Que se visualiza pequeño paralelos y estáticos o ausente)". Esta letal señal obliga o derivar crudo o cirujano base sospechando crasa limitante asiduo fofu el perimetral asombro de descartar o diagnosticar masas ocultas oncológicas linfóideas y purulento tumoral y o basilar de el oncológico de fofa base o en Linfomas Letales asiduos puros o similares general o tumores neoplásicos immaculado de asiduos estancos basilar purulento de recesión asidua a biopsias generales rancias.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un niño de seis años ha tenido seis episodios documentados de amigdalitis bacteriana en el último año. Los padres consultan si corresponde realizar amigdalectomía. ¿Cuál es la conducta correcta?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Amigdalectomía. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Amigdalitis recurrente requiere 7 episodios en 1 año, o 5/año por 2 años, o 3/año por 3 años para indicar cirugía
- Dos o más abscesos periamigdalinos son indicación de amigdalectomía (algunos autores aceptan uno solo)
- Amígdala palatina hipertrófica con apnea obstructiva del sueño es indicación obstructiva principal
- En niños, la causa más frecuente de apnea obstructiva es hipertrofia amigdalina y adenoidea
- Amígdala lingual hipertrófica puede causar obstrucción de vía aérea y requiere amigdalectomía
- Amígdala asimétrica o con aspecto anormal es indicación quirúrgica por sospecha de neoplasia (linfoma o carcinoma)

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (AMIGDALECTOMIA)

PREGUNTA 1

Un niño de seis años ha tenido seis episodios documentados de amigdalitis bacteriana en el último año. Los padres consultan si corresponde realizar amigdalectomía. ¿Cuál es la conducta correcta?

- A)** Indicar amigdalectomía de inmediato porque ya tiene seis episodios
- B)** No cumple criterios aún; se requieren siete episodios en un año para indicar cirugía
- C)** Indicar amigdalectomía porque en niños el umbral es de cinco episodios
- D)** Derivar a cirugía por riesgo de absceso periamigdalino
- E)** Realizar amigdalectomía si tiene además hipertrofia amigdalina

PREGUNTA 2

Un adulto de treinta años presenta su segundo absceso periamigdalino en dos años, ambos tratados con drenaje quirúrgico. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A)** Continuar con manejo médico y drenaje ante nuevos episodios
- B)** Indicar amigdalectomía porque ya presenta dos abscesos periamigdalinos
- C)** Esperar a un tercer episodio antes de indicar cirugía
- D)** Indicar amigdalectomía solo si tiene también amigdalitis frecuentes
- E)** Solicitar TAC para evaluar extensión antes de decidir cirugía

PREGUNTA 3

Una mujer de cuarenta y cinco años consulta por sensación de cuerpo extraño en la garganta. Al examen se observa amígdala derecha notoriamente mayor que la izquierda, sin signos inflamatorios. ¿Cuál es la conducta?

- A)** Observar y controlar en seis meses si no cambia
- B)** Tratar con antibióticos por posible amigdalitis crónica
- C)** Indicar amigdalectomía con biopsia por sospecha de neoplasia
- D)** Solicitar ecografía cervical y manejar según resultado
- E)** Indicar amigdalectomía solo si hay síntomas obstructivos nocturnos

RESUMEN: AMIGDALECTOMIA

La amigdalectomía es una intervención quirúrgica cuyas indicaciones están bien definidas y resultan fundamentales para el EUNACOM. Las indicaciones se agrupan en infecciosas y obstructivas. Dentro de las infecciosas, la más relevante es la amigdalitis recurrente, que se define según criterios precisos: siete episodios bacterianos documentados en un año, cinco episodios por año durante dos años consecutivos, o tres episodios por año durante tres años. Esta exigencia cuantitativa se justifica porque las amigdalitis bacterianas tienden a disminuir con el tiempo en muchos pacientes, por lo que no se indica cirugía ante pocos episodios. El antecedente de dos o más abscesos periamigdalinos también constituye indicación quirúrgica absoluta, aunque algunos autores aceptan uno solo como suficiente. Las indicaciones obstructivas son igualmente importantes. La amígdala palatina hipertrófica que causa apnea obstructiva del sueño es una indicación de amigdalectomía, especialmente en niños donde representa la causa más frecuente de apnea. Asimismo, la amígdala lingual hipertrófica puede obstruir la vía aérea y constituye indicación quirúrgica. Una indicación de suma importancia clínica es la sospecha de neoplasia: cualquier amígdala asimétrica o con apariencia anormal debe ser extirpada y enviada a biopsia, pues puede corresponder a un linfoma o carcinoma de células escamosas amigdalino. Desde el punto de vista del EUNACOM, el aspecto más evaluado es identificar correctamente las indicaciones y sus umbrales. Es fundamental distinguir que la amigdalectomía no se realiza por pocas amigdalitis ni por amigdalitis virales, sino solo cuando se cumplen criterios estrictos. La sospecha de malignidad siempre prima como indicación independiente del número de episodios infecciosos previos. El candidato debe también reconocer que la amígdala lingual es una entidad separada de la amígdala palatina y puede requerir cirugía por obstrucción.